

TÉTANO — VACINA +/- SORO CONFORME A FERIDA

PROFILAXIA NO FERIMENTO — VACINA E IMUNOGLOBULINA

Situação vacinal	Ferida limpa/superficial	Ferida suja/de risco
Incerta ou < 3 doses	Vacina (dT)	Vacina (dT) + imunoglobulina/soro antitetânico
>= 3 doses, última < 5 anos	Nada	Nada
>= 3 doses, última 5-10 anos	Nada	Vacina (dT)
>= 3 doses, última > 10 anos	Vacina (dT)	Vacina (dT) +/- imunoglobulina conforme risco
Imunossuprimido / ferida de alto risco	Avaliar reforço	Vacina + imunoglobulina (mesmo se bem vacinado)

O QUE TORNA A FERIDA 'DE RISCO' (TETANOGENICA)

AVALIAR A FERIDA + O ESTADO VACINAL

- Feridas de risco: contaminadas com terra/fezes/saliva, profundas, com tecido desvitalizado, por esmagamento, queimaduras, mordeduras, perfurações
- Feridas com corpo estranho, feridas puntiformes e ferimentos por arma de fogo
- Ferida limpa e superficial tem baixo risco
- A decisão de profilaxia combina o TIPO de ferida e o ESTADO VACINAL do paciente
- Imunoglobulina antitetânica é para os não/mal vacinados com ferida de risco (e imunossuprimidos)
- Limpeza e desbridamento da ferida são parte essencial da prevenção

DOSES DA PROFILAXIA

Rx

VACINA E IMUNOGLOBULINA/SORO

Vacina dT (dupla adulto): IM; completar o esquema de 3 doses se incompleto, com reforço a cada 10 anos

Imunoglobulina antitetânica humana (TIG): 250-500 UI IM, em local diferente da vacina

Soro antitetânico (SAT) heterólogo: 5.000 UI IM quando a imunoglobulina humana não estiver disponível (testar/observar reação)

Aplicar vacina e imunoglobulina em locais e seringas diferentes

Gestante: dTpa indicada conforme calendário; a profilaxia do ferimento segue as mesmas regras

Sempre limpar e desbridar a ferida (reduz o ambiente anaeróbio do *C. tetani*)

Suporte ao Plantão Médico

TÉTANO INSTALADO — RECONHECIMENTO

Aspecto	Detalhe
Agente/toxina	Clostridium tetani; a tetanospasmina bloqueia a inibição neuronal -> espasmos
Trismo	Rigidez de masseteres (dificuldade de abrir a boca) — sinal precoce
Riso sardônico	Contratura da face
Opistótono	Hiperextensão do tronco por espasmo da musculatura paravertebral
Espasmos generalizados	Desencadeados por estímulos (luz, som, toque); disfunção autonômica
Consciência	Preservada (o paciente está lúcido durante os espasmos)

TRATAMENTO DO TÉTANO ACIDENTAL

Pilares do Tratamento

- Ambiente calmo, escuro e silencioso (reduzir estímulos que desencadeiam espasmos)
- Neutralizar a toxina circulante: imunoglobulina antitetânica humana
- Eliminar o agente: limpeza/desbridamento + antibiótico (metronidazol é o de escolha)
- Controle dos espasmos: benzodiazepínico (diazepam/midazolam) em dose alta; sulfato de magnésio adjuvante
- Casos graves: bloqueio neuromuscular + ventilação mecânica em UTI
- Disautonomia: manejo hemodinâmico em UTI

Não Esquecer

- O tétano NÃO confere imunidade — vacinar durante/após a doença
- Metronidazol é preferido à penicilina (que pode ter efeito pró-convulsivante)
- Sedação e analgesia adequadas; profilaxia de TVP e cuidados de UTI
- Suporte nutricional (gasto energético alto pelos espasmos)
- Notificação compulsória
- Prevenção é a melhor estratégia: vacinação e cuidado correto das feridas

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Avaliar TIPO de ferida (limpa x de risco) e ESTADO vacinal para decidir a profilaxia
- ☐ Ferida de risco em não/mal vacinado: vacina + imunoglobulina antitetânica
- ☐ Aplicar vacina e imunoglobulina em locais diferentes; limpar e desbridar a ferida
- ☐ Reconhecer o tétano instalado: trismo, riso sardônico, opistótono, espasmos com consciência preservada
- ☐ Tratar: ambiente calmo + imunoglobulina + metronidazol + benzodiazepínico; UTI nos graves
- ☐ Vacinar mesmo após a doença (não imuniza) e notificar

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com ferimento perfurante contaminado com terra, esquema vacinal desconhecido. Qual a profilaxia?

- A) Apenas limpeza da ferida
- B) Vacina (dT) + imunoglobulina antitetânica
- C) Apenas vacina, sem imunoglobulina
- D) Apenas antibiótico
- E) Nenhuma medida é necessária

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com ferida limpa e superficial, com 3 doses de vacina e última dose há 3 anos. Qual a conduta?

- A) Vacina + imunoglobulina
- B) Apenas vacina
- C) Nenhuma profilaxia adicional é necessária
- D) Imunoglobulina isolada
- E) Antibiótico profilático

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual antibiótico é o de escolha no tratamento do tétano acidental?

- A) Penicilina cristalina
- B) Metronidazol
- C) Ceftriaxona
- D) Azitromicina
- E) Vancomicina

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual achado é típico do tétano e ajuda a diferenciá-lo de outras causas de rebaixamento?

- A) Coma profundo desde o início
- B) Espasmos musculares (trismo, opistótono) com consciência PRESERVADA
- C) Febre alta com rigidez de nuca isolada
- D) Paralisia flácida ascendente
- E) Movimentos coreicos

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Após um episódio de tétano, qual conduta sobre a vacinação é correta?

- A) Não é necessário vacinar, pois a doença confere imunidade
- B) Deve-se vacinar, pois o tétano NÃO confere imunidade
- C) A vacina é contraindicada após a doença
- D) Basta a imunoglobulina ao longo da vida
- E) A vacinação só é necessária se houver novo ferimento

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Ferida de risco (perfurante, contaminada com terra) em paciente com estado vacinal desconhecido/incompleto exige vacina (dT) + imunoglobulina antitetânica, além de limpeza e desbridamento da ferida.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Ferida limpa e superficial em paciente com 3 doses e última dose há menos de 5 anos NÃO requer profilaxia adicional. A decisão sempre combina o tipo de ferida e o tempo desde a última dose.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O metronidazol é o antibiótico de escolha no tétano, preferido à penicilina (que tem efeito antagonista do GABA e pode favorecer convulsões/espasmos). Associa-se à limpeza/desbridamento da ferida (eliminar o *C. tetani*).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O tétano cursa com espasmos musculares intensos (trismo, riso sardônico, opistótono) desencadeados por estímulos, com a CONSCIÊNCIA PRESERVADA — o paciente está lúcido durante os espasmos, o que ajuda a diferenciá-lo de outras causas.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O tétano NÃO confere imunidade (a quantidade de toxina que causa a doença é mínima e não estimula resposta imune protetora). Por isso o paciente deve ser vacinado durante/após a doença para prevenir novos episódios.

SM24
Suporte ao Plantão Médico